

ERNST GENOMMEN WERDEN

Dein Weg zur richtigen Diagnose

Für Frauen, die ahnen, dass sie neurodivergent sein könnten.

Für die, denen gesagt wurde, sie seien zu empathisch, zu erfolgreich oder einfach nur erschöpft.

Für die, die eine Diagnose haben und ahnen, es war die falsche.

Für die, deren Kind neurodivergent ist oder eine Diagnose bekommen hat, und die sich seitdem fragen: War das bei mir vielleicht auch immer so?

Und für die, die noch nirgends waren, weil die Angst zu groß ist, wieder nicht gehört zu werden.

Kurz vorab:

Dieser Guide stellt keine Diagnose und ersetzt keine ärztliche oder klinisch-psychologische Abklärung. Er hilft dir, deine eigene Erfahrung zu ordnen, zu verstehen, warum gerade Frauen so oft durchs Raster fallen, und dich für ein Gespräch zu wappnen, das dich endlich ernst nimmt. Diagnostizieren können nur qualifizierte Fachleute. Was du hier bekommst, ist etwas anderes: die Sprache und die Werkzeuge, um dich selbst ernst zu nehmen.

Da war schon lange dieses Gefühl

Du funktionierst. Von außen sieht alles okay aus. Und trotzdem ist da dieses leise, hartnäckige Gefühl: Irgendwas passt nicht. Irgendwas war schon immer anders. Und niemand konnte dir bisher sagen, was.

Vielleicht hast du schon eine Diagnose bekommen. Angst. Depression. Erschöpfung. Borderline Persönlichkeitsstörung. Vielleicht hat es sich im ersten Moment sogar richtig angefühlt, weil es endlich ein Wort gab. Aber je länger du damit lebst, desto mehr spürst du: Das erklärt nicht alles. Es erklärt nicht, warum du dein Leben lang das Gefühl hattest, mehr Kraft für Dinge zu brauchen, die anderen leichtfallen.

Vielleicht warst du auch schon bei jemandem und bist mit einem Satz nach Hause gegangen, der dich kleiner gemacht hat als vorher. Oder du warst noch nie irgendwo, weil genau diese Angst dich zurückhält: wieder nicht gehört zu werden. Wieder abgewiegelt. Wieder das Gefühl, dass du dir das alles nur einbildest.

Dieser Guide ist für genau diesen Moment gemacht. Nicht um dir zu sagen, was du hast. Sondern um dir zu zeigen: Dein Bauchgefühl hat einen Grund. Und du darfst ihm nachgehen.

Warum gerade dich so lange niemand richtig gesehen hat

Das Wichtigste zuerst, und bitte lies es zweimal: Dass du so lange durchgerutscht bist, liegt nicht daran, dass mit dir zu wenig los war. Es liegt daran, dass das Raster zu eng war.

Die diagnostischen Kriterien, nach denen bis heute gesucht wird, wurden ursprünglich an kleinen, auffälligen Jungen entwickelt. Der zappelige Bub, der nicht stillsitzen kann. Nach diesem Bild wird bis heute oft gesucht. Und in dieses Bild passt du als Frau, die gelernt hat zu funktionieren, einfach nicht hinein.

Was bei dir wahrscheinlich anders gelaufen ist

- **Masking.** Du hast früh gelernt, dich anzupassen, zu beobachten, zu spiegeln. Was von außen wie „sie kommt ja klar“ aussieht, hat dich innerlich enorm viel Kraft gekostet. Das nennt sich Masking, und **es verdeckt fast alles, wonach gesucht wird.**
- **Kompensation.** Du bist intelligent und sprachlich stark, also hast du Schwierigkeiten überspielt, bevor sie jemandem auffallen konnten. Genau diese Stärke hat dich unsichtbar gemacht.
- **Anderes Erscheinungsbild.** Bei Mädchen und Frauen zeigt sich vieles nach innen statt nach außen: Grübeln, Selbstzweifel, innere Unruhe, Gedankenkreisen, Erschöpfung. Das wird schnell als Angst oder Depression gelesen, nicht als das, was darunter liegt.
- **Die Genderdatenlücke.** Über neurodivergente Frauen wird bis heute deutlich weniger geforscht. Was man nicht gründlich untersucht, das übersieht man auch leichter.

Nicht du warst zu unauffällig. Das Raster war zu eng.

Alles, was dich hat durchrutschen lassen, war eigentlich eine Leistung: dich anpassen, kompensieren, funktionieren. Nur hat diese Leistung dich Kraft gekostet und dich gleichzeitig unsichtbar gemacht.

Die Sätze, die du vielleicht gehört hast

Manche Frauen schaffen den Schritt und gehen zu Fachleuten, und dann bekommen sie einen Satz zu hören, der die Verunsicherung nur größer macht. Hier sind die häufigsten, und was wirklich dahintersteckt.

„Sie sind zu empathisch für Autismus.“

Empathie und Neurodivergenz schließen sich nicht aus. Viele neurodivergente Frauen nehmen die Gefühle anderer sogar besonders stark wahr, manchmal bis zur Überforderung. Empathie ist kein Ausschlusskriterium, sie ist oft Teil des Bildes.

„Sie können ja Augenkontakt halten, also schließe ich Autismus aus.“

Augenkontakt ist kein Ausschlusskriterium, auch wenn sich dieser Mythos hartnäckig hält. Viele autistische Frauen haben sich Augenkontakt bewusst antrainiert, weil sie früh gemerkt haben, dass er von ihnen erwartet wird. Was für die Fachperson wie Mühelosigkeit aussieht, ist oft antrainierte Anstrengung. Manche schauen auch auf die Nasenwurzel oder die Stirn, damit es wie Blickkontakt wirkt. Dass du es kannst, sagt nichts darüber aus, was es dich kostet.

„Sie sitzen ganz ruhig hier, ich sehe keine Hyperaktivität.“

Hyperaktivität zeigt sich bei Frauen und im Erwachsenenalter oft gar nicht nach außen, sondern nach innen. Das ständige Gedankenkreisen, die innere Unruhe, das Gefühl, nie richtig abschalten zu können, all das ist Hyperaktivität, nur eben unsichtbar. Dazu kommt: In einer angespannten Terminsituation halten sich viele besonders zusammen. Ausgerechnet der Moment, in dem beurteilt wird, ist der Moment, in dem am meisten maskiert wird.

„Sie haben doch Freunde, das spricht dagegen.“

Beziehungen zu haben schließt Neurodivergenz nicht aus. Viele neurodivergente Frauen sind sozial sehr fähig, weil sie soziale Regeln bewusst gelernt und geübt haben, wo andere sie intuitiv mitbekommen. Freundschaften zu führen und sie gleichzeitig anstrengend zu finden, sich danach ausgelaugt zu fühlen oder sie mühsam aufrechtzuerhalten, das passt sehr wohl ins Bild. Die Frage ist nicht, ob du Menschen hast, sondern was dich das Zusammensein kostet.

„Dafür sind Sie zu intelligent.“

Intelligenz und Neurodivergenz haben nichts miteinander zu tun. Was Intelligenz allerdings kann, ist Schwierigkeiten lange überdecken. Kluge Frauen entwickeln oft ausgefeilte Strategien, um Probleme auszugleichen, bevor sie jemandem auffallen. Genau diese Fähigkeit hat viele erst spät oder gar nicht erkannt werden lassen. Intelligent zu sein ist kein Gegenbeweis, es ist oft der Grund, warum es so lange niemand gesehen hat.

„Da müsste ja schon in der Kindheit etwas gewesen sein.“

Das stimmt insofern, als Neurodivergenz angeboren ist und nicht erst im Erwachsenenalter entsteht. Aber daraus folgt nicht, dass es damals jemandem auffallen musste. Bei vielen Mädchen war sehr wohl etwas, es wurde nur anders gedeutet: als schüchtern, verträumt, überangepasst, als das brave Mädchen oder die zu Sensible. Die Hinweise waren da. Es hat nur niemand nach ihnen gesucht, weil man beim falschen Bild geblieben ist.

„Das ist gerade sehr in Mode, viele glauben, sie hätten das.“

Dass mehr über Neurodivergenz gesprochen wird, ist kein Grund, dich weniger ernst zu nehmen, sondern der Grund, warum du überhaupt die Worte für dein Erleben gefunden hast. Jahrzehntlang wurde eine ganze Gruppe übersehen. Dass diese Menschen jetzt sichtbar werden, ist kein Trend, sondern das Nachholen von etwas, das viel zu lange gefehlt hat. Deine Frage verdient eine ehrliche Abklärung, egal wie viele andere sich dieselbe Frage gerade stellen.

„Dafür sind Sie zu erfolgreich, zu organisiert, zu klug.“

Funktionieren zu können heißt nicht, dass es dich nichts kostet. Viele Frauen halten ihr Leben mit enormem Aufwand zusammen, mit Listen, Kontrolle, Selbstdisziplin und der ständigen Angst, dass alles kippt. Dieser Preis ist von außen unsichtbar. Er zählt trotzdem.

„Das ist nur Ihre Angst. Ihre Depression. Ihr Stress.“

Oft stimmt beides: Die Angst oder die Erschöpfung sind echt, aber sie sind die Folge, nicht die Ursache. Wer jahrelang gegen ein System ankämpft, das nicht für das eigene Nervensystem gemacht ist, wird irgendwann erschöpft und ängstlich. Das zu behandeln, ohne das Darunterliegende zu sehen, greift zu kurz.

„Das hätte man früher bemerkt.“

Nein, nicht zwangsläufig. Genau das ist der Punkt. Eine ganze Generation von Mädchen ist durchgerutscht, weil man nach dem falschen Bild gesucht hat. Spät erkannt zu werden ist die Regel, nicht die Ausnahme.

Fehldiagnose oder Zusatzdiagnose? Ein wichtiger Unterschied

Viele Frauen glauben, ihre bisherige Diagnose sei einfach falsch gewesen. Manchmal stimmt das. Oft ist es aber etwas anderes, und dieser Unterschied nimmt viel Verwirrung raus.

Häufig war die bisherige Diagnose nicht falsch, sondern unvollständig. Die Angst war da. Die Depression war da. Aber sie waren nicht das ganze Bild, sondern das, was obendrauf entstanden ist, weil das Darunterliegende jahrelang niemand gesehen hat.

Der Unterschied in einem Satz:

Nicht „Angst STATT Neurodivergenz“ sondern oft „Angst ALS FOLGE von jahrelang unerkannter Neurodivergenz“. Das eine ersetzt das andere nicht. Es liegt darunter.

Das ist auch der Grund, warum eine genauere Abklärung so viel verändern kann: Nicht weil deine bisherige Diagnose gelöscht wird, sondern weil endlich das ganze Bild sichtbar wird. Und mit dem ganzen Bild verändert sich, was dir wirklich hilft.

Und manchmal war es doch die falsche Schublade...

Es gibt aber auch die Fälle, in denen eine Diagnose nicht nur unvollständig war, sondern schlicht daneben. Bestimmte Labels werden bei Frauen auffällig oft vergeben, gerade weil unerkannte Neurodivergenz von außen so aussehen kann. Vielleicht erkennst du dich hier wieder:

- **Generalisierte Angststörung.** Ein Klassiker. Das ständige Grübeln, die innere Unruhe, die Überforderung im Alltag werden als Angststörung gelesen. Dass die Angst oft daher kommt, permanent gegen ein nicht passendes System anzuarbeiten, wird dabei übersehen.
- **Persönlichkeitsstörungen, vor allem Borderline.** Wird häufig vergeben, wo eigentlich AuDHS dahintersteckt. Emotionale Intensität, Rejection Sensitivity, das Gefühl innerer Leere, Beziehungsstress durch Masking und Erschöpfung überschneiden sich stark mit dem, was als Borderline oder emotional instabile Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wird.
- **Wiederkehrende Depression.** Immer wiederkehrende erschöpfte Phasen werden als wiederkehrende Depression behandelt. Dass es sich um autistischen Burnout oder um die Folgen von jahrelangem Masking handeln könnte, kommt oft gar nicht erst auf den Tisch.
- **Hochsensibilität.** Ein weiches, unscharfes Etikett, das gern vergeben wird, wenn jemand sensibel und schnell überreizt wirkt. Es beschreibt ein Symptom, erklärt aber nichts und führt selten zu wirklich passender Unterstützung.
- **Bipolare Verstimmung.** Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit werden manchmal vorschnell als bipolar eingeordnet, obwohl es sich um die schnellen emotionalen Wechsel und die Zyklus-Effekte handeln kann, die bei AuDHS häufig vorkommen.

Wichtig: Das heißt nicht automatisch, dass deine Diagnose falsch war. All diese Dinge gibt es wirklich, und sie können auch zusätzlich bestehen. Es heißt nur: Wenn sich deine Diagnose nie ganz stimmig angefühlt hat, bist du mit diesem Gefühl nicht allein und nicht undankbar. Du darfst genauer hinschauen lassen.

Wo du hingehst, entscheidest mit

Bevor du dich überhaupt auf ein Gespräch vorbereitest, kommt ein Schritt, den kaum jemand erklärt und der so viel ausmacht: die richtige Stelle finden. Ein großer Teil der abwiegelnden Sätze von oben passiert nämlich einfach bei der falschen Adresse.

Erst mal: Wer macht überhaupt was?

Es gibt zwei Wege, die oft durcheinandergehen, und es hilft enorm, den Unterschied zu kennen.

- **Psychiatrische Diagnose.** Eine ärztliche Diagnose durch eine Fachärztin oder einen Facharzt für Psychiatrie. Dieser Weg kann eine Diagnose stellen und, wenn es passt, auch Medikamente verschreiben. Gespräche sind hier oft kürzer getaktet.
- **Klinisch-psychologische Diagnostik.** Eine ausführliche testpsychologische Abklärung durch eine klinische Psychologin oder einen klinischen Psychologen. Dieser Weg nimmt sich meist mehr Zeit, arbeitet mit Fragebögen, Tests und Biografie, verschreibt aber keine Medikamente.

Beides kann sinnvoll sein, oft sogar in Kombination. Ich bin ein großer Fan von psychologischer Diagnostik. Welcher Weg für dich der richtige ist, entscheidest du am besten gemeinsam mit einer Fachperson. Wichtig ist nur, dass du weißt: Es gibt diese zwei Wege, und du darfst gezielt danach fragen. (Die genauen Zuständigkeiten unterscheiden sich je nach Land ein wenig, in Österreich, Deutschland und der Schweiz ist es nicht überall identisch.)

So wählst du wirklich gut aus

Du bist der Auswahl nicht ausgeliefert. Du darfst dir die Stelle aussuchen, und du darfst ganz genau hinschauen. Bitte sei unbedingt wählerisch, denn es gibt leider im gesamten DACH-Raum noch VIEL ZU WENIGE Fachleute, die sich gut auskennen. Die Recherchearbeit liegt hier leider bei den Betroffenen. Aber es lohnt sich hier etwas Zeit zu investieren und zu warten (bei den wenigen Spezialist*innen gibt es leider oft lange Wartelisten). Was du tun kannst:

- **Empfehlungen einholen.** Frag in Communitys, Selbsthilfegruppen oder bei anderen spätagnostizierten Frauen nach guten Adressen. Wer schon dort war, weiß, wer wirklich zuhört. (Für Wien melde dich gerne bei mir via DM!)
- **Auf Spezialisierung achten.** Schau auf die Webseite: Schreibt die Person explizit, dass sie Erfahrung mit Neurodivergenz bei Frauen und im Erwachsenenalter hat? Genau das ist das entscheidende Signal. Wer das benennt, kennt das Bild, das bei dir wahrscheinlich anders aussieht.
- **Erwachsene, nicht nur Kinder.** Erwachsenendiagnostik ist ein eigenes Feld. Eine Stelle, die vor allem Kinder abklärt, ist für dich vielleicht nicht die beste Wahl.

Warnzeichen, bei denen du weitersuchen darfst:

Jemand, der Masking nicht kennt oder abtut. Jemand, der sagt „das wächst sich aus“ oder „das haben heute alle“. Jemand, der dich nach fünf Minuten einsortiert, ohne deine Biografie anzuschauen. Das ist kein Urteil über dich, das ist ein Zeichen, dass die Adresse nicht passt. Jemand der sich nicht beides (Autismus und ADHS) ansieht, ist – finde ich – auch nicht die richtige Adresse.

Eine Abfuhr an der falschen Stelle ist keine Antwort auf deine Frage. Sie sagt nur etwas über die Stelle aus, nicht über dich.

So gehst du vorbereitet in ein Gespräch, das dich ernst nimmt

Wenn du die richtige Stelle gefunden hast, hilft dir Vorbereitung enorm. Nicht, weil du dich beweisen musst, sondern weil dein eigenes Wissen über dich das Wertvollste ist, das du mitbringst.

Sammle deine eigenen Beispiele

Konkrete Situationen sind stärker als Begriffe. Nicht „ich bin unkonzentriert“, sondern „ich lese eine Seite dreimal und weiß danach nicht, was drinstand“. Schreib dir vorher auf, was dir im Alltag wirklich schwerfällt und was es dich kostet.

Denk an früher

Vieles wird nach Hinweisen aus der Kindheit gefragt. Was haben Lehrerinnen gesagt? Warst du die Verträumte, die Vorlaute, die Überangepasste? Alte Zeugnisse, Erinnerungen von Familie, all das kann helfen. Wenn du wenig weißt, ist das auch okay, sag es einfach so.

Hätte, wenn du abgewiegt wirst

Leg dir vorher ein paar Sätze zurecht, damit du im Moment nicht sprachlos bist:

- „Ich funktioniere nach außen, aber es kostet mich sehr viel. Genau das möchte ich abklären lassen.“
- „Ich weiß, dass sich das bei Frauen oft anders zeigt. Darauf würde ich gern eingehen.“
- „Ich weiß, dass Blickkontakt halten und empathisch sein KEIN Ausschlussgrund für Autismus ist. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, Sie wissen über Autismus bei Frauen Bescheid.“
- „Ich hätte gern eine ausführliche Abklärung, nicht nur eine schnelle Einschätzung.“

Du darfst nach einer Zweitmeinung fragen

Wenn du dich nicht gesehen fühlst, ist das ein legitimer Grund, woanders weiterzusuchen. Eine Zweitmeinung ist kein Misstrauen und keine Unverschämtheit. Sie ist dein gutes Recht. Du suchst nicht so lange, bis dir jemand recht gibt. Du suchst so lange, bis dir jemand richtig zuhört.

Zum Schluss

Egal, was am Ende dabei herauskommt: Dass du dich ernst nimmst, ist schon der wichtigste Schritt.

Und während du den Guide jetzt auf dich wirken lässt, oder schon recherchierst wo du hingehen magst oder vielleicht sogar schon auf deinen Diagnostik-Termin wartest: **Du brauchst keine Diagnose, um dir jetzt schon zu erlauben, gut zu dir zu sein!**

Atme. Du hast nichts verpasst und nichts falsch gemacht.

Du kommst gerade dort an wo du hingehörst.

Wie es weitergehen kann

Ein nächster Schritt, der vielen hilft, ist herauszufinden, welche Umgebungen dich eigentlich auslaugen und welche dich tragen. Das ist oft der Punkt, an dem sich das diffuse „irgendwas stimmt nicht“ das erste Mal richtig sortiert.

Hol dir meinen gratis Umgebungs-Check

Schau in meine Bio oder schreib mir das Wort UMGEBUNG bei irgendeinem Post als Kommentar und ich schicke dir den Umgebungs-Check zu. Drei einfache Fragen für sechs Lebensbereiche, damit du siehst, wo dein Nervensystem aufatmet und wo es ständig auf Alarm ist!

Und wenn du magst, folg mir für mehr davon. Ich bin selbst spät diagnostiziert und rede hier über all das, was mir damals niemand erklärt hat.

Wichtiger Hinweis

Dieser Guide beruht auf persönlicher Erfahrung und allgemein verfügbarem Wissen. Er stellt keine Diagnose, ersetzt keine ärztliche oder klinisch-psychologische Abklärung und keine professionelle Behandlung. Wenn du den Verdacht auf eine Neurodivergenz oder eine andere Diagnose hast, wende dich bitte an qualifizierte Fachleute. Wenn es dir psychisch sehr schlecht geht, such dir bitte zeitnah professionelle Unterstützung.